

TEMA 52



ANEXO.

ENCUESTA A LAS PSH, 2.022 (INE).

ESTRATEGIA SIN HOGARISMO “DIGNITAS”, 2.022-2.027.

HAY QUE SUSTITUIR DEL TEMA ORIGINAL LOS APARTADOS "2" Y "8".

2.- ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES.

La **Encuesta a las Personas sin Hogar del año 2022** ofrece información sobre las condiciones de vida de las personas sin hogar de 18 o más años que han sido usuarias de los centros asistenciales de alojamiento y/o restauración ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Todos los resultados se refieren a este colectivo.

2.1.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Un total de 28.552 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 han pernoctado en espacios públicos o alojamientos de fortuna (cajeros, portales, coches …).

La mayor parte de las personas sin hogar son hombres (76,7%). No obstante, cabe destacar que la proporción de mujeres que están en esta situación ha aumentado hasta el 23,3% respecto al 19,7% del año 2012.

El 51,1% de las personas sin hogar tiene menos de 45 años, el 43,3% entre 45 y 64 años y los mayores de 64 años representan el 5,5%. La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años.

El 50,1% tiene nacionalidad española y el 49,9% extranjera. El 93,3% de los españoles está empadronado en algún municipio, frente al 75,8% de los extranjeros.

Por lo que respecta a los extranjeros, la mayoría tiene nacionalidad de un país de África (53,3%), seguido por América (25,9%) y Europa (16,7%). En cuanto al tiempo de residencia, el 43,1% de los extranjeros sin hogar lleva más de cinco años en España.

En la población extranjera sin hogar se observa mayor peso de las edades más jóvenes. El 68,0% tiene menos de 45 años, frente al 34,3% de los españoles. Esta diferencia se acentúa en el grupo de edad de 18 a 29 años.

Por cada 100.000 habitantes hay 86,6 personas sin hogar. Por comunidades autónomas, las mayores tasas se sitúan en la Ciudad Autónoma de Ceuta (391,4), País Vasco (315,9), Comunidad Foral de Navarra (214,7) y Cantabria (182,6). Por su parte, Comunitat Valenciana (14,8), Cataluña (42,6), Castilla-La Mancha (45,0) y Región de Murcia (48,4) registran las tasas más bajas.

En el caso de la Comunidad de Madrid habría una tasa de 67,6 habitantes.

Desde el punto de vista del tiempo que llevan sin hogar, el 32,5% de las personas lleva menos de un año sin disponer de un alojamiento, el 27,0% entre uno y tres años y el 40,5% lleva más de tres años sin alojamiento propio.

El 36,6% de las mujeres lleva sin hogar menos de un año, frente al 31,2% de los hombres.

2.2.- MOTIVOS DE ESTAR SIN HOGAR.

Las personas destacaron como principales motivos por los que se quedaron sin hogar el tener que empezar de cero tras llegar desde otro país (28,8% del total), la pérdida del trabajo (26,8%) y el desahucio de su vivienda (16,1%).

Por nacionalidad, el motivo principal por el que se quedaron sin hogar los extranjeros fue por tener que empezar de cero tras migrar (54,1%). En el caso de los que tienen nacionalidad española, porque perdieron el trabajo (26,7%).

2.3.- VÍNCULOS FAMILIARES Y SOCIALES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Para completar las características sociales de las personas sin hogar es necesario conocer el contexto familiar antes y después de llegar a esta situación y cómo se relacionan socialmente.

El 24,9% de las personas de este colectivo dice tener pareja, y de estas, solo la mitad convive con ella. Atendiendo a su situación legal, el 11,0% está casado, el 23,0% está separado o divorciado, el 63,7% soltero y el 2,3% viudo.

En cuanto a la descendencia, cinco de cada 10 personas sin hogar tienen hijos.

En relación a los antecedentes familiares, se observa que hasta cumplir los 18 años el 77,5% del total ha vivido con sus padres, el 10,7% solo con su padre o su madre, el 5,8% con sus abuelos u otros familiares, el 3,9% en una institución de acogida y el 2,2% con otras personas que no eran familiares.

Las situaciones familiares más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 años han sido la falta de dinero (45,1%), el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar (37,1%) y el paro prolongado de algún miembro (27,3%).

El 20,0% de las personas sin hogar dice haber vivido hasta los 18 años en un entorno familiar sin problemas o conflictos graves.

2.4.- CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

El 89,2% de las personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo lugar. El 40,3% ha dormido alguna noche en alojamientos colectivos (el 39,7% en un albergue o residencia, el 0,4% en centros de ayuda al refugiado y el 0,2% en centros de acogida a mujeres maltratadas).

Otro 24,7% ha pernoctado en pisos o pensiones facilitados por una ONG u organismo y el 35,0% restante se ha alojado al margen de la red asistencial existente, bien en espacios públicos (15,8%), alojamientos de fortuna (9,7%) o en pisos ocupados (9,5%).

El 14,5% de las personas sin hogar se ha quedado sin comer o cenar algún día en la semana previa a la entrevista. Atendiendo al lugar de pernoctación, los mayores porcentajes de personas que se han quedado sin comer se dieron en las personas que duermen en espacio público (39,3%) y en alojamientos de fortuna (30,5%).

2.5.- FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

En lo relativo a los estudios terminados, el 65,0% de la población sin hogar ha alcanzado un nivel de educación secundaria, el 23,8% de estudios primarios o inferiores y el 11,3% estudios superiores. Cabe destacar que el 12,4% de las mujeres tiene estudios universitarios, frente al 7,7% de los hombres.

La edad media de finalización o abandono de los estudios fue de 16,9 años.

Desde el punto de vista de la situación laboral, lo más destacable de la población sin hogar es su baja participación. El 5,4% dice estar trabajando, el 71,2% manifiesta estar en desempleo, el 6,4% en situación de invalidez, el 4,1% jubilado o retirado y el 12,9% restante dice encontrarse en otra situación.

Por edades, el grupo de edad con mayor porcentaje de personas que manifiestan estar en desempleo es el de 30 a 34 años (76,6%), seguido del grupo de 45 a 64 años (75,0%) y del de 18 a 29 años (63,3%).

Más de la mitad de las personas que manifiestan estar en desempleo dice que no está buscando empleo (52,3%). Las principales razones por las que no lo busca son por motivos de salud (42,5%) y por no tener papeles –autorización para trabajar– (21,8%).

2.6.- FUENTES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Las principales fuentes de ingresos de la población sin hogar son las prestaciones públicas (Renta Mínima de Inserción, Ingreso Mínimo Vital, prestaciones por desempleo, pensiones contributivas y no contributivas y otros tipos de prestaciones y ayudas públicas) que son percibidas por el 32,6% de las personas.

La Renta Mínima de Inserción, prestación pública más específica para personas con problemas de integración, es la principal fuente de ingresos para el 7,6% de las personas sin hogar. El 5,0% indica que su mayor fuente de ingresos es el Ingreso Mínimo Vital y otro 6,1% recibe principalmente pensiones no contributivas.

Otras fuentes de ingresos son el dinero que les da un familiar (6,9%), el que obtienen por su trabajo (6,7%) y el que les dan las ONG (6,5%).

Hay un 29,9% de personas sin hogar que declaran no tener ninguna fuente de ingresos.

Respecto a los bienes y servicios en los que gastan mayoritariamente su dinero destaca la comida (64,1% del total), seguida del tabaco (20,8%), la ropa (18,7%) y el alojamiento (18,0%).

2.7.- LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

En cuanto a la cobertura sanitaria, el 80,5% del colectivo de personas sin hogar afirma que dispone de tarjeta sanitaria. Atendiendo a la nacionalidad, el 68,0% de los extranjeros tiene tarjeta sanitaria, frente al 92,9% de los españoles.

El 55,8% de las personas sin hogar declara tener buena o muy buena salud, mientras que el 14,9% la percibe como mala o muy mala.

La percepción del estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres. El 57,3% de los varones declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 51,2% de las mujeres.

El 37,4% de las personas sin hogar manifiesta tener alguna enfermedad crónica. Las mujeres (43,6%) en mayor medida que los hombres (35,5%). La más frecuente es el trastorno mental, que afecta al 9,4% de las personas sin hogar. Este tipo de enfermedad crónica está diagnosticado en el 9,1% de los hombres y en el 10,7% de las mujeres.

Acerca de la percepción que tienen las personas sin hogar sobre su salud mental, el 59,6% presenta algún síntoma depresivo, porcentaje que asciende al 67,8% en las mujeres. Estos porcentajes son significativamente más elevados que los de la población general residente en hogares, obtenidos en la Encuesta Europea de Salud del año 2020, según la cual el porcentaje de personas mayores de 15 años que presentaron algún síntoma depresivo fue del 12,9%, cifra que ascendió al 16,6% en el caso de las mujeres.

Por grupos de edad, perciben menos síntomas depresivos los mayores de 64 años (48,0%) y los menores de 30 años (el 48,7%). Por su parte, los que tienen entre 45 y 64 años son los que declaran más síntomas depresivos (64,5% con alguna sintomatología).

También es importante destacar que el 20,5% tiene alguna discapacidad. El 19,5% tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Respecto a hábitos de vida relacionados con la salud, el 55,7% de las personas sin hogar señala que no consume alcohol y el 40,5% que lo hace ligera o moderadamente. Solo un 3,9% de personas manifiesta un consumo alto o excesivo de alcohol. Entre las mujeres hay más personas abstemias que entre los hombres.

Atendiendo a la nacionalidad, el 49,8% de los españoles manifiesta no consumir alcohol frente al 61,4% de los extranjeros. Por continentes, los mayores porcentajes de abstemios se dan en Asia, Oceanía y Apátridas (83,6%) y en África (71,9%).

En relación con el consumo de drogas, el 57,7% dice que nunca ha consumido y el 42,3% que lo ha hecho alguna vez, aunque en el último mes solo lo hizo el 18,3%. La proporción de mujeres que han consumido alguna vez (30,3%) es menor que la de hombres (45,9%).

Desde el comienzo de la pandemia COVID-19, el 70,3% dice no haber tenido síntomas y cree que no se ha contagiado, el 27,2% ha estado hospitalizado, aislado o en cuarentena y el 2,5% piensa que se puede haber contagiado pero no le han realizado ningún test.

Ha recibido la vacuna contra la COVID-19 el 85,1% de las personas de este colectivo, el 9,0% rechazó vacunarse y al 3,3% no le han avisado para recibir la vacuna. Una de cada cuatro personas que durmieron en espacios públicos o alojamientos de fortuna no se ha vacunado.

2.8.- SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar, especialmente vulnerables y excluidas o en riesgo de exclusión social, tienen como finalidad cubrir sus necesidades básicas.

Las personas sin hogar solicitan principalmente, además de los servicios de alojamiento (62,7% de las personas) y comedor (65,8%), incluidos en la definición de persona sin hogar a efectos de esta encuesta, otros servicios sociales como los de información, orientación y acogida (47,4%) y los servicios de higiene (44,3%).

Los servicios más concedidos a las personas sin hogar son los de comedor (64,2%), alojamiento (51,2%) y orientación, información y acogida (43,9%).

En cuanto a la opinión que tienen las personas sin hogar sobre las ayudas que han recibido, el 61,8% opina que le ayudaron bastante o mucho, mientras que el 38,2% opina que le ayudaron poco o nada.

El 82,0% de las personas sin hogar señalan que necesitarían una vivienda o habitación para poder salir de la situación en la que se encuentran.

Un 78,0% afirma que necesitaría un trabajo y un 38,6% una prestación económica. El 88,7% de los extranjeros cree que tener un trabajo les ayudaría a salir de su situación, frente al 67,3% de los españoles.

2.9.- IGUALDAD Y RELACIÓN CON LA JUSTICIA.

Un factor importante asociado a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de las personas sin hogar es su exposición a las agresiones o delitos.

El 50,3% de las personas sin hogar ha sido víctima de algún delito o agresión. Los delitos y agresiones más frecuentes han sido los insultos y amenazas, robos y agresiones.

Por otra parte, el 79,1% de las personas sin hogar se siente poco o nada discriminado. El 7,1% manifiesta sentirse constantemente discriminado.

Por nacionalidad, el 76,1% de los españoles se siente nada o poco discriminado, frente al 82,2% de los extranjeros.

Respecto a su relación con la justicia, el 44,9% de las personas sin hogar ha sido detenido o denunciado alguna vez. De estas, el 52,6% ha sido condenado por los tribunales.

Por nacionalidad, el 57,1% de los españoles ha sido condenado alguna vez, frente al 42,5% de los extranjeros.

VARIACIÓN DE LAS PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PSH EN 2.022 RESPECTO AL AÑO 2.012.

	Año 2.022	Año 2.012	Diferencia
Personas sin hogar	28.552	22.938	5.614
Mujeres sin hogar	23,3	19,7	3,6
PSH extranjeras	49,9	45,8	4,0
PSH que se quedaron sin hogar debido a la pérdida de trabajo	26,8	45,0	-18,2
PSH con estudios secundarios	65,0	60,2	4,8
PSH que pernoctan en alojamientos colectivos	40,3	43,9	-3,6
PSH que pernoctan en espacio público o alojamientos de fortuna	25,5	27,7	-2,2
PSH que llevan menos de 1 año sin alojamiento propio	32,5	31,9	0,6
PSH que llevan más de 3 años sin alojamiento propio	40,5	44,5	-4,0
PSH que dicen estar en desempleo	71,2	77,8	-6,6
PSH con trabajo	5,4	3,6	1,8
PSH con tarjeta sanitaria	80,5	80,2	0,3
PSH cuya principal fuente de ingresos es la RMI o el IMV	12,6	11,4	1,2
PSH sin fuente de ingresos	29,9	19,5	10,4
PSH que consumen alcohol	44,4	44,1	0,3

8.- LAS PERSONAS SIN HOGAR EN LAS ESTRATEGIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. DIGNITAS: ESTRATEGIA MUNICIPAL SOBRE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO, 2.022-2.027.

La primera **Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 (ENIPSH-I),** aprobada por el Consejo de Ministros en 2015, constituye el primer planteamiento nacional que establece las actuaciones a implementar por la Administración General del Estado y orienta las acciones de Comunidades Autónomas y corporaciones locales para reducir el sinhogarismo, centrándose en la prevención, la sensibilización y defensa contra la discriminación, la seguridad de vida de las personas en situación de sinhogarismo y el refuerzo del sistema de atención al sinhogarismo.

A nivel autonómico, el **Plan de Inclusión de Personas Sin Hogar de la Comunidad de Madrid (2016-2021)** reúne las iniciativas de la administración regional para avanzar en la inserción de las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. Este Plan establece como prioridades el refuerzo del sistema de ayuda, la prevención de situaciones de sinhogarismo y la atención a las personas en situación de calle. Asimismo, el Plan articula actuaciones asociadas al acceso de derechos, el impulso de la autonomía y la activación de las personas en situaciones de sinhogarismo.

De forma simultánea, la Estrategia Municipal para la Prevención y Atención del Sinhogarismo 2015-2020 (Estrategia LARES) introduce un desarrollo estratégico que recoge por primera vez el proceso de desarrollo y consolidación de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar en la ciudad de Madrid.

La Estrategia LARES marca el primer hito y el punto de partida para el desarrollo de políticas municipales de sinhogarismo cada vez más transversales y participativas. Esta Estrategia se articuló alrededor de la sensibilización y el compromiso social, la prevención de procesos de exclusión, el empoderamiento y la coordinación entre actores. La Estrategia aportó importantes aprendizajes en materia de diseño y planificación que han sido recogidos en la elaboración del presente documento.

A lo largo de la vigencia de la Estrategia LARES se avanzó en la experimentación de nuevos modelos de intervención como Housing First y Housing Led, con el objetivo de complementar la atención que se realizaba hasta el momento en los recursos de atención a personas en situación de sinhogarismo.

Al margen de los antecedentes citados, en los últimos años se han dado **cambios de enfoque** que han ido consolidándose, muchos de ellos impulsados a nivel europeo.

A este respecto resulta fundamental mencionar la **Plataforma Europea para combatir el Sinhogarismo (Acuerdo de Lisboa, 2021)**, en la que se visibiliza la necesidad de proporcionar las condiciones para evitar las situaciones de calle y la estancia prolongada en servicios de alojamiento provisionales a través de la provisión de vivienda y servicios sociales orientados a la autonomía de las personas.

Asimismo, desde 2019 la Red de Atención a las Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid se está transformando de manera positiva, adaptando la infraestructura pública y el paradigma de intervención con las personas sin hogar.

La nueva **Estrategia Municipal sobre Prevención y Atención a las personas en situación de sinhogarismo en Madrid, 2022-2027 (Estrategia "Dignitas"),** recoge el aprendizaje del proceso de transformación que ya está en marcha y asume la responsabilidad de marcar el rumbo que deben seguir las políticas públicas en materia de sinhogarismo durante los próximos años.

Resulta fundamental destacar que esta Estrategia no debe leerse como un documento de planificación aislado, sino que debe enmarcarse en el **Nuevo Sistema Público de Servicios Sociales, aprobado por Unanimidad en la sesión 7/2022 ordinaria del Pleno de 31 de mayo de 2022**.

8.1.- UNA APROXIMACIÓN AL SINHOGARISMO.

8.1.1.- FACTORES DE RIESGO Y DESENCADENANTES.

El sinhogarismo debe entenderse como un **continuum de situaciones de precariedad y exclusión** de la vivienda. La entrada de una persona en alguna de las categorías ETHOS responde a una combinación de circunstancias de riesgo y desencadenantes a nivel estructural e individual.

Es difícil explicar las causas del sinhogarismo, ya que es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores. Sin embargo, es posible identificar algunas causas y factores de vulnerabilidad que llevan a una persona a quedarse sin hogar o a estar en riesgo de perderlo.

Es importante tener en cuenta que las causas y las situaciones de vulnerabilidad son diferentes para cada persona. Asimismo los factores, individualmente considerados, no explican por sí mismos las causas del sinhogarismo, pero pueden aumentar el riesgo de caer en esta situación cuando coinciden varias causas.

Resulta esencial, por tanto, reflexionar sobre las causas o factores de riesgo vinculados al sinhogarismo, en la medida en que la comprensión de los factores que llevan a las situaciones de exclusión residencial extrema ha de permitir reflexionar sobre las políticas que deben articularse para la prevención y el abordaje de este fenómeno.

En ese sentido, habitualmente tiende a considerarse que el sinhogarismo es un proceso generado como consecuencia de la **interacción dinámica entre cuatro grandes grupos de causas –estructurales, institucionales, relacionales y personales–,** que normalmente aparecen de forma simultánea o combinada.

A modo de resumen, a continuación, se identifican los factores de vulnerabilidad más prominentes en la ciudad de Madrid:

FACTORES ESTRUCTURALES.	**FACTORES INSTITUCIONALES.**
. Desempleo. . Migración. . Ingresos insuficientes. . Falta de vivienda asequible. . Desahucios por impago de alquiler.	. Obstáculos para acceder a las prestaciones sociales y demoras en la tramitación. . Sistema de protección que no garantiza ingresos suficientes para una vida autónoma. . Falta de coordinación entre las distintas redes de protección.
FACTORES PERSONALES.	**FACTORES RELACIONALES.**
. Problemas de salud física y mental. . Barreras idiomáticas. . Adicciones. . Sucesos vitales de vida estresantes.	. Rupturas afectivas. . Violencia de género. . Falta de redes de apoyo en la comunidad.

8.1.2.- MODELOS DE ABORDAJE DEL FENÓMENO.

La respuesta política al sinhogarismo está en proceso de cambio y evolución. Los modelos más tradicionales han ido adaptándose a nuevas tendencias que partían de una atención a las necesidades básicas y se dirigen hacia la búsqueda de una intervención más individualizada, eficaz y específica.

De esta forma, los servicios sociales han abierto oportunidades para el despliegue de nuevos modelos enfocados a la desinstitucionalización y a la promoción de la autonomía. En la actualidad, en las redes de atención a personas en situación de sinhogarismo coexisten diversos modelos de intervención.

El Ayuntamiento de Madrid también ha ido sumándose a esta tendencia y el abordaje del sinhogarismo desde las políticas y los programas sociales ha evolucionado desde el asistencialismo y la gestión de emergencias sociales, hacia enfoques más preventivos, integrales y orientados al ejercicio de la ciudadanía y los Derechos Humanos.

Las principales tendencias se destacan a continuación:

MODELOS DE INTERVENCIÓN INTEGRADOS.

En estos modelos se reconoce la **naturaleza multidimensional del sinhogarismo** y, en consecuencia, se ofrece una **atención integral y acompañamiento social centrado en el contexto de cada persona**, abordando distintos obstáculos de acceso a oportunidades para la recuperación de los vínculos sociales.

Así, en los programas de intervención se han integrado **programas de apoyo psicosocial, programas de formación e inserción laboral, además de los programas sociosanitarios para el tratamiento de enfermedades mentales graves y adicciones a sustancias.**

El objetivo de este modelo es ayudar a la persona a superar los obstáculos que dificultan la inclusión social y el mantenimiento de una vida autónoma e independiente.

MODELOS ORIENTADOS A LA VIVIENDA.

Esto modelos abogan por la reconstrucción de los proyectos vitales a través de la estabilidad vital, los vínculos afectivos y la vida en comunidad.

Se trata de un enfoque que garantiza el **acceso a la vivienda** para la puesta en marcha de procesos vitales dirigidos a las personas excluidas que necesitan niveles significativos de ayuda para retomar la autonomía.

Los modelos orientados a la vivienda ofrecen una vivienda individual o compartida a las personas en riesgo o situación de sinhogarismo que necesitan apoyos para retomar su vida. Este enfoque realiza, además, un acompañamiento profesional adaptado a cada persona.

Una de las modalidades más conocidas del modelo "housing" es "**housing first**" (Vivienda Primero), que dirige su intervención a las personas con necesidades múltiples y complejas. Lo primero que se proporciona en los programas housing first es una vivienda estable.

En la intervención se integran servicios, apoyos, programas de cuidado en diversos ámbitos (adicciones, salud física, salud mental, etc.), con la diferencia fundamental de que el acceso y el mantenimiento de la vivienda no está condicionado a la adhesión de las personas usuarias a dichos programas, como sucedía en los modelos más tradicionales.

Al mismo tiempo, estos programas impulsan el empoderamiento y la participación de las personas usuarias (en calidad de ciudadanos), la vida en comunidad y en entornos normalizados.

ENFOQUES PREVENTIVOS.

Los enfoques preventivos amplían el alcance y margen de actuación de las políticas y programas sociales para identificar personas en riesgo de exclusión residencial y activar respuestas institucionales, todo ello con el fin de evitar que caigan en una situación de sinhogarismo.

Así, se despliegan medidas dirigidas a distintas categorías ETHOS (como personas sin viviendas, con viviendas inseguras e inadecuadas) por ejemplo, personas afectadas por procesos de desahucio o individuos que están en procesos de salida de instituciones que, por sus circunstancias, tienen un riesgo elevado de sinhogarismo.

Se trata, principalmente, de la **búsqueda activa de colectivos en riesgo y del desarrollo de una infraestructura que, mediante la acción preventiva, reduce el número de personas que caen en situaciones de sinhogarismo**, libera la presión de los dispositivos de atención (contribuyendo a una atención más personalizada y de calidad) y contribuye al objetivo de reducir el sinhogarismo.

8.2.- DIAGNÓSTICO DEL SINHOGARISMO EN MADRID.

8.2.1.- DIMENSIÓN DEL SINHOGARISMO EN MADRID.

El recuento nocturno de personas en situación de sinhogarismo es una herramienta de medición oficial, cuya metodología permite un acercamiento sistemático y longitudinal a la realidad del sinhogarismo en sus distintas dimensiones: situaciones de calle, personas alojadas en centros de acogida y otros recursos de la Red de Atención a Personas sin Hogar.

El recuento de personas sin hogar que estaba previsto realizar en el año 2020 no pudo llevarse a cabo debido a la crisis sanitaria ocasionada por la situación de pandemia originada por el COVID 19.

Superada esa situación de pandemia, se ha trabajado conjuntamente con otras ciudades de nuestro país, con el impulso y bajo la coordinación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en una metodología común para los recuentos nocturnos de Personas sin Hogar en España. Este documento plantea recuentos alternos en años impares, y será el marco metodológico en el que se realizará el recuento del año 2023.

En cuanto a la situación particular de Madrid, los datos del último recuento nocturno nos remiten al año 2018. Si bien para este documento, con el fin de mostrar la información conforme a criterios homogéneos basados en la herramienta de medición oficial, se ha tomado principalmente la información oficial y los datos derivados del último recuento realizado en la ciudad de Madrid, lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una información valiosísima que deriva del trabajo y registro diario de información de los Equipos de Calle que trabajan con la población en situación de sinhogarismo y de los espacios de coordinación entre todos los Centros y Programas de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar.

Los datos resultantes del citado recuento del año 2018 identificaron 650 personas sin techo. En cuanto a otras categorías ETHOS, el último recuento identificó un total de 1.250 personas en centros de atención a personas sin hogar y/o emergencias sociales, 675 personas en pisos tutelados o de programas housing first, 234 en centros de acogida para inmigrantes y un estimado de 189 personas en asentamientos.

Con relación a las personas en situación de calle, desde el año 2006 la evolución del número de personas detectadas en calle ha registrado un promedio de 634 personas, llegando a máximos de 701 y 764 entre 2012 y 2014, respectivamente, y a mínimos de 524 en 2016.

Interesa destacar que los informantes clave consultados para la elaboración de este diagnóstico advierten que esta problemática ha aumentado en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia de la COVID-19, que ha significado para muchas personas la pérdida de empleo, vivienda y la pérdida progresiva de todas las redes de protección.

Así, tanto los recursos de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar como las entidades y equipos que ofrecen apoyo a esta población detectan un aumento en el número de demandas de alojamiento y atención.

8.2.2.- CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA.

SEXO.

En los últimos años, tanto la **feminización de la pobreza como el sinhogarismo en las mujeres se han empezado a visibilizar.**

Todas las entidades, actores institucionales e informantes clave consultados para el desarrollo del diagnóstico coinciden en el incremento de mujeres en situación de sinhogarismo, la mayoría de ellas provenientes de **contextos de riesgo, violencia de género y factores estresantes**.

También los profesionales de los Equipos de calle que trabajan con la población en situación de sinhogarismo concluyen que está aumentando el porcentaje de mujeres en esta situación.

Las mujeres que pernoctan en la calle son más vulnerables y tienden a esconderse para no exponerse a situaciones de riesgo, dificultando su identificación en los recuentos. De hecho, no se constata un cambio claro si nos atenemos exclusivamente a esta fuente.

No obstante, los datos de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar puestos en común con las informaciones de todos los agentes implicados, nos permiten concluir que, efectivamente, se detecta una **mayor presencia de las mujeres en situación de sinhogarismo**.

Esta realidad constatada nos ha permitido trabajar adecuando los Programas y los Centros de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar para dar una repuesta tanto en clave de prevención –"Programa No Second Night" (año 2021)- como bajo una mirada de recuperación –"Centro de Acogida Beatriz Galindo para mujeres sin hogar víctimas de violencia" (año 2021)-.

EDAD.

Atendiendo al perfil por edad, los datos más recientes de las personas en situación de sinhogarismo señalan una **edad media declarada de 47,1 años, siendo el intervalo de 40-49 años el más representando en este grupo de población**.

No obstante, llama la atención que la edad mínima de las personas detectadas en 2018 descendió a 18 años, lo que indica que cada vez más personas jóvenes caen en situación de sinhogarismo.

Las personas jóvenes están cada vez más representadas en la población acogida por los dispositivos municipales de atención a personas sin hogar. Desde los recursos de la Red Municipal y desde las entidades del Tercer Sector que ofrecen servicios a las personas en situación de sinhogarismo se observa y se alerta de esta nueva tendencia.

Los agentes sociales y actores institucionales consultados para este diagnóstico informan que hay una presencia significativa de jóvenes extutelados, otros jóvenes migrantes y jóvenes LGTBIQ+ en este grupo de población. También esta realidad constatada nos he llevado a adaptar recursos a esta población -Programa de Jóvenes en las Unidades de Convivencia del Centro de Acogida Juan Luis Vives (año 2022), Programa Housing Led y Programa "A Tiempo" (años 2022)-.

NACIONALIDAD.

Otra variable que ha de destacarse es la nacionalidad, dada la emergencia social provocada por la migración y la búsqueda de protección internacional por parte de población de origen extranjero, sumado a los obstáculos que enfrentan en materia de inclusión social. Esto ha generado un **incremento del peso de la población extranjera en los recuentos y datos disponibles**. Las personas extranjeras en situación de sinhogarismo proceden (principalmente) de Europa del Este, países del Magreb, América Latina, África subsahariana y Asia.

Según el recuento de 2018, el **61,1% de las personas detectadas son de origen extranjero**, mientras que la población española representa el 38,9% de esta población. Asimismo, la población extranjera en situación de sinhogarismo ha permanecido por encima del 50% desde 2006. Parte de esta realidad se puede explicar por los obstáculos de inclusión social que enfrentan las personas de origen extranjero, especialmente en términos de regularidad administrativa e inserción laboral.

Las entidades consultadas para este diagnóstico informan que desde 2018 han aumentado los casos de personas solicitantes de asilo (mayoritariamente jóvenes y familias con hijos menores) en espera de resolución o con la solicitud de protección internacional denegada.

En otros casos, se registra la presencia de jóvenes extutelados de origen extranjero que caen en situaciones de sinhogarismo tras salir del sistema de protección, como se ha señalado anteriormente.

SITUACIÓN LABORAL.

En general, las personas en situación de sinhogarismo se encuentran en desempleo o realizando trabajos precarios. De acuerdo con los datos del recuento de 2018, el 76,3% de las personas en situación de sinhogarismo se encuentra desempleada, mientras que solo el 23,7% realiza algún tipo de trabajo (usualmente en la economía sumergida).

Los trabajos que realizan las personas en situación de sinhogarismo **son precarios**: el 92% de las personas entrevistadas en el recuento afirmaron no tener contratos regulares, trabajando una media de 24,6 horas a la semana, en actividades como chatarrería, construcción, ayudas en bares o mudanzas.

Por otro lado, del total de las personas que se encuentran desempleadas, el 27,6% de las personas se encuentran inscritas en el SEPE. Si bien sigue siendo un porcentaje muy bajo, debe destacarse que este porcentaje ha aumentado con respecto al 2016, pasando de una proporción del 18,8% a una del 27,6% en 2018. El aumento de personas en situación de sinhogarismo inscritas en el SEPE se puede explicar por las acciones de los equipos de trabajo en calle, los apoyos ofrecidos por las entidades sociales, así como las actividades de información y divulgación de los subsidios y prestaciones a las que tienen derecho las personas en situación de sinhogarismo.

OTROS INGRESOS.

La mayoría de las personas en situación de calle obtienen ingresos pidiendo dinero en calle (43,5%), seguido de otras actividades -chatarrería, malabares, animación, vendiendo revistas y kleenex- (21,1%), ingresos de la Renta Mínima de Inserción -RMI- (15,0%) y pensiones (5,4%).

A nivel de ingresos y prestaciones, **el porcentaje de personas en situación de sinhogarismo que perciben ingresos de la RMI continúa siendo bajo a nivel autonómico y local**. De acuerdo con el Informe de Rentas Mínimas de Inserción publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2020 solo el 4,13% de las personas sin hogar percibían RMI. Aunque la tendencia sigue siendo baja, en la ciudad de Madrid se observa un **leve aumento en el porcentaje de personas en situación de sinhogarismo que perciben ingresos de la RMI**. Así, las personas que declaran percibir ingresos de la RMI pasaron de ser el 12,3% en 2014 al 15% en 2018. Por otro lado, los recuentos nocturnos indican un aumento en las personas que afirman recibir otro tipo de pensiones, pasando del 1,2% en 2014 al 5,4% en 2018.

Asimismo, se constata un **mayor porcentaje de personas que declaran percibir pensiones de jubilación** que llegaron a un 3,4% en 2018.

NIVEL DE ESTUDIOS.

Con relación al nivel de estudios, los datos de las fuentes de información disponibles revelan que la gran mayoría de esta población solo tiene estudios primarios o inferiores, aunque se ha observado un mayor porcentaje de personas en situación de sinhogarismo que declaran tener estudios superiores.

ESTADO CIVIL.

El estado civil de las personas en situación de sinhogarismo es otra variable que debe contemplarse, en tanto que es uno de principales factores que detonan situaciones de sinhogarismo (como, por ejemplo, los divorcios y las rupturas afectivas). Así, el 17% de las personas consultadas en el recuento nocturno de 2018 declaran las rupturas afectivas como uno de los principales motivos que los llevaron a una situación de sinhogarismo, mientras que en 2016 este porcentaje era inferior (11,8%).

El estado civil más común en las distintas situaciones de sinhogarismo es la soltería, seguido del divorcio o la separación, con algunas diferencias entre la situación residencial. Por ejemplo, el porcentaje de personas casadas es mayor en las personas en situación de calle y el porcentaje de las personas separadas es mayor en las personas que residen en centros.

SALUD FÍSICA Y MENTAL.

El ámbito de la salud es una variable fundamental que ha de considerarse en la población en situación de sinhogarismo, dado que suelen padecer enfermedades físicas, mentales, algún tipo de discapacidad o patologías duales que se agravan con el tiempo por falta de tratamientos apropiados y la propia situación de calle. De hecho, los informantes clave consultados para este diagnóstico revelan la presencia de personas en situación de sinhogarismo con **problemas de salud mental y trastornos cognitivos graves, personas con algún tipo de discapacidad y personas con adicciones a sustancias psicoactivas** (incluyendo a jóvenes).

En términos generales, las fuentes de información disponibles demuestran que la **mayoría de las personas en situación de sinhogarismo** padecen algún problema de salud, siendo levemente superior en las personas que habitan en pisos. Esto puede deberse a que las personas en pisos y centros han pasado por procesos que han facilitado el reconocimiento de la enfermedad (algo que no siempre sucede en las personas con trayectoria en calle), han sido diagnosticados con una enfermedad en el marco de los programas en los que participan y posiblemente tienen una mayor conciencia sobre su estado de salud que las personas en situación de calle.

Otra cuestión relevante en el acceso a los derechos es la **disponibilidad de tarjeta sanitaria**. Según el IX Recuento Nocturno, una buena proporción de las personas en calle no cuenta con ella (41,9%), mientras que las personas que residen en centros y pisos sí tienen acceso a este documento (60,9% y 58,1%, respectivamente), pudiendo acceder a los servicios sanitarios en la ciudad de Madrid.

Ha de tenerse en consideración la especial vulnerabilidad que viven las personas extranjeras en situación de sinhogarismo, especialmente aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. Este hecho resulta un obstáculo adicional para acceder al sistema sanitario y recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Con respecto a las **adicciones**, los recuentos nocturnos revelan que se ha registrado un incremento en el porcentaje de personas que declaran a las drogas y el alcohol como uno de los principales motivos que los llevó a dormir en la calle. En el caso de las drogas, este porcentaje pasó de un 1,7% en 2016 a un 9,4% en 2018, y en el alcohol de un 7,6% en 2016 al 11,7% en 2018.

8.2.3.- NECESIDADES Y ASPECTOS TRANSVERSALES EN LAS POLÍTICAS A IMPLANTAR.

Las personas en situación de sinhogarismo viven situaciones de continua necesidad que atañen a todos los ámbitos de su vida. Si bien existen **necesidades comunes** a todas las personas en situación de sinhogarismo, es necesario identificar las **necesidades específicas** de algunos grupos como son: mujeres, jóvenes e inmigrantes. Es, por tanto, necesario identificar las necesidades comunes y específicas que requieren las personas de este grupo poblacional, con el objetivo de ofrecer una respuesta institucional adecuada y ajustada a las diversas circunstancias que viven las personas en exclusión.

NECESIDADES COMUNES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO.

Las personas en situación de sinhogarismo son personas vulnerables que requieren de apoyos para retomar sus proyectos vitales y gozar plenamente de los derechos humanos.

Como tal, la atención no solo debe ajustarse a sus necesidades, sino que además debe respetar su poder de decisión y la situación individual en la que cada persona se encuentra, a través de **servicios orientados a la persona y con enfoque de derechos humanos**. Atendiendo a las causas que llevaron a las personas a situaciones de sinhogarismo, deben mencionarse otras necesidades asociadas a la recuperación de la vida autónoma como son el **acceso a empleos formales y de calidad y la percepción de ingresos para recuperar la autonomía económica** (tanto por la vía laboral, como la percepción de prestaciones e ingresos mínimos). En ese sentido, las personas en situación de sinhogarismo requieren de apoyos y programas dirigidos a favorecer la inserción en el mercado laboral, incluyendo la formación y la capacitación laboral.

Además, las personas en situación de calle requieren de **prestaciones para cubrir necesidades básicas**, en especial alimentación, transporte, higiene y saneamiento, sanidad, vestimenta, entre otras necesidades básicas vinculados a los centros de día.

De especial relevancia es la **garantía de ingresos** (RMI, IMV, PNC, rentas por trabajo, etc.) como un derecho subjetivo y un impulso fundamental para que las personas en situación de sinhogarismo cubran sus necesidades básicas y tengan un soporte económico mientras logran recuperar la autonomía.

Por otro lado, la **salud mental** de las personas en situación de calle es un aspecto fundamental que debe ser cubierto desde la red sanitaria de atención primaria y desde la Red de Salud Mental especializada y de competencia autonómica, no solo porque la situación de calle implica el deterioro continuo de la persona, sino también porque su reinserción en la sociedad pasa necesariamente por el acceso a los servicios de salud mental y tratamientos adecuados.

La mayoría de las personas en situación de sinhogarismo manifiestan pasar la mayor parte del día en solitario. En ese sentido, el **apoyo sociocomunitario y el apoyo emocional** son necesidades fundamentales, ya que se trata de personas que en la mayoría de los casos han roto sus vínculos familiares y sociales. Por este motivo, la intervención con apoyo comunitario es cada vez más relevante. Algunas de las necesidades anteriormente expuestas, se pueden resumir en el acceso a servicios sociales, acceso a la salud, el acceso a la vivienda y a la protección social.

Para ello, las personas requieren de **servicios de información, acompañamiento y mecanismos que faciliten el acceso al empadronamiento** (como requisito para acceder a los servicios mencionados) y la solicitud de los distintos servicios y prestaciones a las que tienen derecho.

Finalmente, las personas en situación de sinhogarismo están cada vez más expuestas **a delitos de odio y aporofobia**. Esta es una realidad que se ha visibilizado por los profesionales que trabajan cotidianamente con esta población, indicando la necesidad de medidas que reduzcan los prejuicios, la estigmatización, la agresión y el rechazo a personas en situación de sinhogarismo.

NUEVAS NECESIDADES Y NECESIDADES ESPECÍFICAS.

La diversidad y emergencia de nuevos perfiles en el sinhogarismo implica el surgimiento de nuevas necesidades y necesidades específicas que se deben atenderse de manera personalizada desde la Red.

A continuación, se destacan algunas necesidades de las personas en situación de sinhogarismo.

Mujeres.

Las mujeres en situación de sinhogarismo se han ocultado e invisibilizado debido a la extrema vulnerabilidad y a la violencia a la que se enfrentan en las calles e incluso en los recursos de la Red Municipal, usualmente pensados para hombres.

Tanto las mujeres como las personas diversas sexualmente requieren de **espacios seguros y con sensibilidad de género** que garanticen su seguridad e integridad física y mental en los recursos y dispositivos de la Red. Esto es así, teniendo en cuenta muy especialmente que provienen de contextos de riesgo, violencia de género y situaciones estresantes que requieren un manejo especializado para recuperar la confianza y acceder a los recursos de la Red, como informan algunas entidades sociales que han sido consultadas para este informe.

Los sucesos vitales estresantes que desencadenan el sinhogarismo en muchas mujeres, en especial la violencia doméstica y de género (sumado a otros factores estresantes como la pobreza, la pérdida de vínculos familiares y la pérdida de la vivienda) tienen impactos profundos en el bienestar y la salud mental de las mujeres.

La consecuencia principal la evidencian las encuestas: el 60,4% de las mujeres en situación de sinhogarismo ha sido víctima de al menos un incidente de odio según el informe HATENTO (2015).

El sinhogarismo femenino requiere de **apoyos y tratamientos psicosociales especializados, prestados por especialistas de la salud mental y otros profesionales con sensibilidad de género**, que permitan abordar la discriminación, los traumas y los abusos que acumulan muchas mujeres en situación de sinhogarismo. Además, las mujeres necesitan servicios de acompañamiento y asesoramiento jurídico para los casos en los que deseen iniciar procesos judiciales en contra de sus agresores.

El miedo y la invisibilidad de las mujeres las ha llevado a ocultarse entre las cifras del sinhogarismo. Por este motivo, requieren apoyos para impulsar el **empoderamiento y la participación social**, llevándolas a trasladar sus necesidades y a exigir sus derechos en calidad de ciudadanas. Dada la dependencia económica a la que muchas mujeres han estado sometidas en el pasado, este colectivo también necesita de programas de **educación financiera y formación para emprender el camino hacia el mercado laboral y la vida autónoma.**

Juventud y personas desinstitucionalizadas.

La juventud cae en la red de sinhogarismo por la falta de oportunidades y por la escasez de programas de prevención. Este colectivo específico necesita del **fortalecimiento de los sistemas de detección y las iniciativas de prevención** para identificar jóvenes en riesgo de exclusión e incorporarles en programas de transición a la vida adulta, un mecanismo eficaz que podría disminuir el porcentaje de jóvenes que terminan en la Red.

Al igual que las mujeres, la juventud en situación de sinhogarismo requiere de **espacios seguros en recursos y dispositivos específicos de atención.** Asimismo, los jóvenes requieren de **alojamientos estables y programas enfocados a la formación y la activación laboral** que favorezcan el acceso a oportunidades y, con ello, la recuperación de sus proyectos de vida para salir lo más pronto posible de la situación de máxima exclusión.

Por otro lado, las personas que finalizan su paso por instituciones (jóvenes extutelados, personas dadas de alta de residencias de salud mental, personas que salen del sistema penitenciario, etc.) tienen mayor riesgo de caer en situaciones de sinhogarismo.

Estas personas requieren de **alternativas habitacionales** desde el momento en que se les informa la fecha de alta, así como también participar en **programas preventivos** que les doten de herramientas para conseguir un trabajo y llevar su vida con normalidad fuera de las instituciones, incluyendo apoyos para acceder a servicios y prestaciones sociales como subsidios y la RMI/ IMV.

Personas inmigrantes.

Las personas migrantes de la Red de sinhogarismo llegan a Madrid con un proyecto migratorio que enfrenta varias dificultades: el idioma, la condición administrativa, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a servicios y protección social.

En ese sentido, es fundamental **intensificar y dotar de estabilidad a la coordinación con la Red de Emergencia Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones** con el fin de que las personas que solicitan acceso al Sistema de Acogida de Protección Internacional no se vean abocadas a una espiral de exclusión que viene determinada por tiempos procedimentales de reconocimiento de derechos muy extensos. Además, las personas migrantes requieren **medidas protectoras frente a los delitos de odio y la xenofobia** que enfrenta este colectivo.

En definitiva, y por todo lo expuesto, la **perspectiva de género, el enfoque interseccional y la mirada hacía la población de origen migrante** serán tres cuestiones transversales que han de estar presentes, en todo momento, en las actuaciones a llevar a cabo a través de una mirada integradora en todas las actuaciones a desarrollar.

8.3.- DESARROLLO ESTRATÉGICO.

ALCANCE.

La Estrategia "Dignitas 2022-2027" identifica el sinhogarismo como un **problema multidimensional y multicausal**. Una realidad, la del sinhogarismo, que gira en torno a la **ausencia de vivienda y a la imposibilidad de acceder a ella** y que impacta de lleno en el desarrollo de las personas, anulando su dimensión social, el pleno disfrute y el ejercicio de los derechos fundamentales.

La ausencia de vivienda y el impacto que ello tiene, en definitiva, en la pérdida progresiva de la dignidad de las personas son dos fenómenos que, sin bien están intrínsecamente relacionados, requieren de herramientas, tiempos y programas distintos para revertirlos.

Esta Estrategia pretende constituirse como el cimiento estable y firme que, poniendo la **dignidad de las personas en el centro de toda actuación**, sirva de base al desarrollo de todas las políticas públicas que influyen en la atención al sinhogarismo de la ciudad de Madrid.

Con un enfoque centrado en la recuperación, orienta sus esfuerzos para **prevenir y reducir las situaciones de sinhogarismo definidas bajo la categoría ETHOS 1 y 2 y 3** (personas en situación de calle, personas en albergues de emergencia y personas en albergues para personas sin hogar).

Si bien el porcentaje de personas bajo estas categorías no es muy elevado con respecto al total de la población en la ciudad de Madrid, sí tiene un componente cualitativo desolador respecto de la exclusión social que provoca y la vulneración de derechos que arrastra.

Este componente es el que determina el compromiso institucional y la necesidad de llegar a todas y a cada de las personas en situación de sinhogarismo.

No obstante, el enfoque preventivo en el que se pone el acento a lo largo de toda la Estrategia supone una mirada más amplia, con el fin de evitar la caída de ninguna persona a las categorías ETHOS 1, 2 y 3, objeto directo de este documento.

Desde este punto de vista, la red de Atención a Personas Sin Hogar no debe ser receptora de problemas asociados a otros sistemas de atención a personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que serán esos sistemas de atención específicos los que puedan y deban procurar la atención más adecuada. Por ello, uno de los objetivos en los que más incide esta Estrategia se basa en **fortalecer los sistemas y mecanismos de coordinación para realizar acciones preventivas**, procurando que nadie atraviese las categorías ETHOS 1, 2 y 3 y que se transite el menor tiempo posible en las categorías 4 a 7.

En suma, la Estrategia pone el acento en la necesidad de abrir, mantener y reforzar espacios de coordinación con otras políticas relacionadas con la pobreza, la vivienda y la igualdad, así como alinear las actuaciones con otras iniciativas gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado. Todo ello con el fin de favorecer la coherencia de las políticas públicas y con el objetivo de dar respuesta a las distintas necesidades de las personas en situación de sinhogarismo.

ENFOQUE Y ESTRUCTURA.

La Estrategia se ha diseñado persiguiendo un **enfoque centrado en el cambio, en la recuperación**. Este enfoque tiene una doble pretensión: por un lado, impulsa las transformaciones que ya se están acometiendo en la Red de Atención a Personas Sin Hogar. Por otro lado, se nutre de la innovación, los aprendizajes y las experiencias de dichas transformaciones para continuar adaptando las respuestas a los retos que se plantean en el diagnóstico.

La **coordinación y cooperación entre Administraciones Públicas**, pero también entre éstas y las Entidades Sociales son un punto clave para el desarrollo y consecución de los objetivos marcados. Resulta fundamental el fortalecimiento de las distintas redes de protección y las acciones preventivas necesarias para evitar que las personas transiten por situaciones de calle o permanezcan largos períodos de tiempo en centros de acogida o instituciones. Además, la Estrategia comprende el sinhogarismo como un fenómeno complejo, que fluctúa a lo largo del tiempo. En ese sentido, se propone una **hoja de ruta** que orienta las acciones municipales en este ámbito, dotada de suficiente flexibilidad para reorientar las actuaciones o incorporar nuevas respuestas con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

Esta hoja de ruta se estructura en los siguientes niveles: **objetivos generales → ejes de actuación → objetivos específicos → líneas de acción.**

En primer lugar, como grandes retos de la Estrategia, se identifican **2 objetivos generales**.

La consecución de cada uno de ellos va a requerir acciones concretas materializadas en **4 ejes de actuación.** Estos ejes de actuación representan los grandes ámbitos temáticos sobre los que se trazarán los **objetivos específicos**. Éstos definen las metas a alcanzar y se concretarán a través de **líneas de acción** que representan los cambios tangibles que se esperan lograr con la Estrategia y que deben contribuir a la prevención y reducción del sinhogarismo.

Abarcando los objetivos generales, los ejes de actuación, los objetivos específicos y las líneas de acción se eleva un **principio inspirador**, la **garantía de hogar**, que estará siempre presente, si bien con distinto grado de intensidad, en cada una de las actuaciones a desarrollar.

OBJETIVOS GENERALES.

El contenido de esta Estrategia y los objetivos generales a alcanzar se proyectan en un doble plano:

Por un lado, **prevenir el sinhogarismo**. Por otro lado, sobre el sinhogarismo existente en la ciudad de Madrid, se marca como objetivo la **reducción significativa de esta realidad** a través de nuevas oportunidades que se concretan en la recuperación de proyectos vitales construidos sobre el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

1. Prevenir el sinhogarismo.

2. Reducir el sinhogarismo existente a través de nuevas oportunidades que se concretan en la recuperación de proyectos vitales construidos sobre el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

PRINCIPIO INSPIRADOR: LA GARANTÍA DE HOGAR.

Los Ejes temáticos que van a concretar los Objetivos Específicos y que van a articular las acciones de esta Estrategia se encuentran inspirados, en mayor o menor medida, sobre el punto de partida que aglutina todas las situaciones de sinhogarismo y que no es otro que la **ausencia de hogar**.

La **Garantía de Hogar**, concebida en su acepción más extensa como **espacio propio donde desarrollar tanto la vida íntima de cada persona** como la proyección más social de las mismas, inspira todas las actuaciones a desarrollar en cada uno de los Ejes Temáticos, Objetivos Específicos y Líneas de Actuación.

EJE TEMÁTICO 1	**Prevención e intervención temprana.**
EJE TEMÁTICO 2	**Adaptación de recursos y metodologías de intervención.**
EJE TEMÁTICO 3	**Empoderamiento, autonomía y participación.**
EJE TEMÁTICO 4	**Conocimiento, sensibilización e innovación.**

EJE 1. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA.

Este Eje busca prevenir el sinhogarismo a través de la detección de casos incipientes, de la atención temprana y de la coordinación con recursos de atención primaria y otras redes de protección.

Todo ello con la finalidad de evitar situaciones de calle y reducir al máximo el tiempo que las personas, recién iniciado este proceso de exclusión severa, pernoctan en las calles o centros de emergencia.

Objetivo específico 1.

Evitar el inicio de procesos de exclusión social severa que pueden derivar en trayectorias de sinhogarismo.

1. Actualización y revisión de los protocolos de actuación conjunta entre los diferentes servicios municipales para la detección de personas en grave riesgo de exclusión.

2. Elaboración de una escala de valoración social que determine la intervención y modalidad en cada caso atendido desde los centros de servicios sociales, orientado a la prevención.

3. Participación en las mesas comunitarias existentes o de nueva creación en los distritos, junto con el tejido asociativo, en la que se aborde la cuestión de la exclusión y del sinhogarismo y se programen acciones preventivas y de visibilización desde el ámbito comunitario.

4. Difusión de información a la ciudadanía sobre los servicios sociales a través de campañas informativas.

5. Elaboración de un protocolo que incorpore la participación de todos los recursos comunitarios en cada centro de servicios sociales, reforzando la dimensión preventiva y comunitaria de los servicios sociales.
Objetivo específico 2. Promover el mantenimiento de la vivienda a personas en riesgo de exclusión social.
6. Facilitación y agilización de apoyos y prestaciones desde la atención social primaria ante situaciones de exclusión social 7. Continuidad en el mantenimiento de Proyectos de Intervención que incorporan Metodologías de Trabajo basadas en acceso a la Vivienda 8. Celebración y mantenimiento de convenios de colaboración para el desarrollo de Programas de alojamiento en vivienda normalizada 9. Ampliación y continuidad del servicio de intermediación Social desde un punto de vista preventivo, cuando pueda producirse una pérdida de vivienda.
Objetivo específico 3. Promover alternativas habitacionales en situaciones de pérdida de vivienda.
10. Promoción de respuesta desde Servicios de Alojamiento Alternativo y desde la Emergencia Social, evitando situación de calle. 11. Apoyo y acompañamiento en la gestión y tramitación de documentación para facilitar el acceso a vivienda pública. 12. Creación y mantenimiento de comisiones de trabajo de coordinación de casos con otras áreas de protección, facilitando alternativas de alojamiento.
Objetivo específico 4. Favorecer una coordinación estable con la red de atención social primaria y otras redes de protección, mediante el fortalecimiento de los mecanismos conjuntos de actuación.
13. Promoción de convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas responsables de Redes de Protección especializadas, encaminadas a prevenir situaciones de sinhogarismo (discapacidad, mayores, salud mental). 14. Intensificación y mantenimiento de la colaboración con otras Áreas municipales (salud, empleo, seguridad, vivienda…) para facilitar actuaciones conjuntas que reviertan situación de exclusión. 15. Creación y mantenimiento de espacios de coordinación de casos y colaboración con otras Áreas de Protección de diferentes Administraciones Públicas, facilitando actuaciones conjuntas. 16. Implementación y participación en los equipos de Coordinación de Casos de Inclusión (ECCI) y de Seguimiento intensivo (ESI) en todos los centros de servicios Sociales, para establecer diseños de intervención más adaptados a las necesidades y situaciones de las personas en situación de exclusión social.

EJE 2. ADAPTACIÓN DE RECURSOS Y DE METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN.

Este eje aspira a profundizar las transformaciones del sistema de atención a personas en situación de sinhogarismo y a profundizar los cambios de la Red a través de la creación de recursos especializados, así como la adaptación de los recursos existentes a las nuevas tendencias: ejercicio de los derechos de la ciudadanía y autonomía.

Objetivo específico 5.

Adaptar los espacios de los centros y programas existentes.

17. Valoración de la reforma y de la reestructuración de los centros de acogida, con la finalidad de generar espacios más individualizados y adaptados a las necesidades específicas de cada persona.

18. Realización de las obras o adaptaciones necesarias con el fin de crear espacios que faciliten una intervención más personalizada y adecuada.

19. Fomento de la mejora de espacios en Programas de la Red no institucionalizados (hospedajes o alojamientos compartidos) con el fin de proporcionar una mayor autonomía.

Objetivo específico 6.

Adaptar el régimen de funcionamiento de los centros y programas.

20. Creación de propuestas de reciclaje, formación y supervisión de los profesionales asignados al trabajo con personas en situación de sinhogarismo, incorporando metodologías de intervención que favorezcan los procesos de vinculación, recuperación y autonomía.

21. Revisión de la normativa interna (Régimen de organización y funcionamiento de los centros), flexibilizando e introduciendo mejoras que se adapten a las necesidades de las personas atendidas, sustituyendo un modelo asistencial por un modelo centrado en la persona.

22. Mantener espacios de Coordinación y Trabajo Técnico de los Coordinadores y Directores de los Recursos de atención a la Red de Personas sin hogar.

23. Creación, mantenimiento e impulso de espacios de coordinación y trabajo técnico con los responsables de las entidades sociales que desarrollen proyectos en colaboración con el Ayuntamiento.

24. Implementación, en su caso, de las propuestas de los grupos de personas usuarias creados para valorar los servicios prestados y sugerir mejoras en los dispositivos.

Objetivo específico 7.

Especializar, en su caso, los centros y programas en función de las necesidades y nuevos perfiles.

25. Detección e identificación de las necesidades no cubiertas en los diferentes recursos de la Red Municipal

26. Valoración de la incorporación, en su caso, de nuevos recursos, servicios, programas o perfiles profesionales que den respuesta a las nuevas necesidades detectadas.

Objetivo específico 8.

Definir itinerarios de actuación e intervención del trabajo con las personas en situación de calle.

27. Creación y Seguimiento de un Protocolo de Actuación con los Servicios comunitarios (Emergencia, Atención Social Primaria, Salud…) ante la detección de personas en situación de calle.

28. Creación y mantenimiento de espacios de coordinación estable con Equipos de intervención y Entidades que trabajen en calle.

29. Incorporación de nuevas metodologías de trabajo que favorezcan la vinculación con las personas en situación de calle más resistentes a la intervención profesional.

30. Creación de una herramienta que permita un mapeo y geolocalización actualizada de las personas en situación de calle.

31. Definición de Protocolos de actuación en agrupamientos y asentamientos de la ciudad

32. Creación y mantenimiento de espacios de coordinación y/o protocolos de actuación que mejoren la convivencia en zonas con mayor impacto.

Objetivo específico 9.

Incorporar metodologías de intervención que eviten la cronificación.

33. Creación de un Procedimiento de valoración específico de acceso a la Red Municipal de atención a Personas sin Hogar, con el objetivo de concretar el recurso más adecuado a las necesidades de las personas.

34. Especialización y Funcionarización de la Puerta Única de Entrada a la Red Municipal de atención a Personas sin Hogar.

35. Fomento, cuando sea posible, de la vinculación y seguimiento con los recursos comunitarios

36. Refuerzo del espacio de trabajo técnico dentro de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar para diseñar y evaluar los procesos individualizados de intervención de cada persona orientados a la autonomía o a la derivación de recursos más específicos y adecuados.

Objetivo específico 10.

Incorporar metodologías y acciones que faciliten la desinstitucionalización y promuevan la autonomía.

37. Mantenimiento de una bolsa de viviendas con itinerarios intensivos de acompañamiento que favorezcan la autonomía y los procesos de desinstitucionalización.

38. Acompañamiento intensivo previo, simultáneo y posterior al proceso de desinstitucionalización, evitando retrocesos y promoviendo el mantenimiento en la situación de autonomía.

Objetivo específico 11.

Incorporar metodologías y acciones que faciliten la salida a vida independiente.

39. Diseñar Programas de gestión económica, planes de ahorro y de acceso a prestaciones económicas para personas que se encuentran en los recursos de la Red Municipal.

40. Establecimiento de coordinaciones y protocolos con los recursos comunitarios que garanticen el ejercicio pleno de derechos, una vez iniciado el proceso de vida independiente.

41. Participación activa en trámites de consulta o información pública de normativa vigente con el fin de visibilizar las diferentes realidades de la exclusión social y estudiar las opciones de acceso a vivienda adecuada.

EJE 3. EMPODERAMIENTO, AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN.

Este eje se fundamenta en el reconocimiento de los derechos fundamentales, así como el empoderamiento para fomentar la autonomía y la participación de las personas en situación de sinhogarismo en la dinámica de los centros o recursos de la Red municipal de Personas sin Hogar y en diversas esferas de la sociedad.

Objetivo específico 12.

Recuperar el sentido vital sobre la base del reconocimiento personal, la autoestima y la autopercepción de las capacidades de cada persona.

42. Incorporar y/o crear espacios de intereses comunes, donde facilitar el trabajo de recuperación del sentido vital de cada persona.

43. Facilitar la visibilización en los espacios comunitarios, entre otros, de las capacidades y del trabajo desarrollado para la recuperación del sentido vital.

Objetivo específico 13.

Fomentar la participación de las personas sin hogar en las decisiones sobre sus itinerarios vitales y en las dinámicas de los centros o recursos donde pudieran estar acogidos.

44. Creación de grupos de personas usuarias en cada recurso de la Red Municipal, para valorar los servicios prestados y sugerir mejoras en los dispositivos

45. Garantizar la relación de confianza con el profesional de su centro de acogida o programa con el fin de valorar los cambios que puedan proponer y su puesta en práctica.

Objetivo específico 14.

Aumentar el acceso de las personas en situación de sinhogarismo a las rentas e ingresos mínimos para la cobertura de necesidades básicas y otras prestaciones.

46. Fomentar el empadronamiento en los lugares de estancia de las personas en situación de sinhogarismo.

47. Acceso a las prestaciones económicas de los Servicios Sociales, con especial incidencia en la tarjeta familia, cuando resulte necesario, para las personas que se encuentran en recursos de la Red Municipal en procesos de autonomía.

48. Acceso y mantenimiento de las prestaciones económicas y rentas mínimas, para personas que se encuentran en los recursos de la Red Municipal.

Objetivo específico 15.

Facilitar el acceso al empleo de las personas en situación de sinhogarismo a través de itinerarios personalizados.

49. Campañas de sensibilización a empresas para promover la contratación de personas en situación de sinhogarismo, incluyendo personas extranjeras que requieran regularizar su situación administrativa.

50. Diseño de programas de Formación y Empleo adaptados a las necesidades de las personas sin hogar atendidas en el Red, contando con la participación de diferentes actores.

51. Generación de empleo a través de alianzas o acuerdos con empresas de inserción y entidades que dispongan de bolsas de trabajo o vacantes para personas en situación de sinhogarismo.

52. Servicios de orientación y acompañamiento desde los recursos en los primeros contactos con potenciales empleadores, así como en las acciones necesarias para emplearse (documentación, apertura de cuentas bancarias, número de seguridad social, etc.).

53. Desarrollo de programas de alfabetización digital y acceso a recursos tecnológicos para facilitar el acceso a puestos de trabajo que exigen habilidades digitales.

54. Reserva de cuotas para personas en situación de sinhogarismo.

Objetivo específico 16.

Mejorar la salud física y mental de las personas en situación de sinhogarismo a través del acceso al sistema sanitario y la provisión de tratamientos especializados.

55. Promoción del incremento de profesionales de salud mental en los programas y dispositivos de la Red para facilitar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de cada paciente y de plazas en recursos específicos a través de acuerdos de colaboración de los servicios implicados.

56. Desarrollo de programas de formación y sensibilización sobre salud psicoemocional al personal de los programas y recursos de la Red.

57. Fortalecimiento y mantenimiento del enfoque de Reducción del Daño en los centros y viviendas de la Red, como una alternativa a la adicción a sustancias.

58. Acceso a diferentes programas que faciliten la detección y diagnóstico de enfermedades, favoreciendo su tratamiento.

59. Creación de protocolos de colaboración y coordinación con hospitales y centros de salud, para garantizar el acceso a los recursos y servicios de salud a los que las personas usuarias tienen derecho.

Objetivo específico 17.

Fomentar la participación social y política de las personas en situación de sinhogarismo en la comunidad.

60. Fomento de la participación de las personas en situación de sinhogarismo en los espacios comunitarios existentes, para favorecer su inclusión social en el entorno.

61. Fomento de la participación de las personas usuarias de la Red de Atención a Personas Sin Hogar en actividades de voluntariado y de ocio alternativo en su entorno comunitario.

EJE 4. CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL.

Este Eje está dirigido a generar conocimiento sobre las personas en situación de sinhogarismo y los impactos de la respuesta institucional para favorecer el diseño de políticas, programas y proyectos basados en la evidencia.

Asimismo, se pretende continuar con el trabajo de sensibilización sobre esta problemática a la población general con el objetivo de reducir la discriminación, los delitos de odio y la aporofobia.

Finalmente, se pretende desarrollar la innovación social en los recursos de la Red para orientar los procesos de intervención y las respuestas institucionales hacia el cambio sistémico y la reducción significativa del sinhogarismo.

Objetivo específico 18.

Profundizar en el conocimiento sobre el sinhogarismo en la ciudad de Madrid.

62. Creación y consolidación del Observatorio del Sinhogarismo de la ciudad de Madrid.

Objetivo específico 19.

Fomentar la innovación social y la transferencia de la experimentación en el ámbito del sinhogarismo.

63. Mapeo de experiencias positivas y destacables de otros ayuntamientos, comunidades autónomas y/o ciudades del mundo que fomenten la innovación en la prevención, atención y erradicación del sinhogarismo en la ciudad de Madrid.

64. Desarrollo de una app (aplicación) que permita a las personas en situación de sinhogarismo conocer y acceder a los servicios y prestaciones que están a su disposición.

65. Creación, consolidación y entrega del Premio anual "Dignitas" de Buenas Prácticas en materia de atención innovadora, prevención o implicación a profesionales de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar u otras entidades de iniciativa social que colaboran con el Ayuntamiento de Madrid.

Objetivo específico 20.

Sensibilizar a la población sobre las causas y diversas problemáticas del sinhogarismo a través de una comunicación proactiva y oportuna, para reducir la discriminación y la estigmatización hacia esta población.

66. Desarrollo de una agenda de sensibilización en entornos comunitarios: centros educativos (colegios, centros de FP y universidades), centros de salud, comercios, asociaciones vecinales, entre otros.

67. Trabajo de sensibilización con medios de comunicación: desarrollo de guías para medios, talleres y materiales con orientaciones sobre cómo abordar el sinhogarismo.

68. Formaciones, charlas y acciones de sensibilización dirigidas a profesionales municipales que interactúan con personas en situación de calle: policía, servicios de limpieza y jardines, personal sanitario, ambulancias, etc.

69. Desarrollo de protocolos de prevención y atención a víctimas de delitos de odio y aporofobia para proteger a las personas en situación de calle, incluyendo procedimientos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Bibliografía

. Encuesta a las personas sin hogar. Año 2.022. Instituto Nacional de Estadística.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf

. Estrategia Municipal sobre Prevención y Atención a las personas en situación de Sinhogarismo. Dignitas. 2.022-2.027.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/PlanesYMemorias/Planes/ServiciosSociales/Ficheros/EstrategiaSinhogarismo2022_2027.pdf